



MÉDICAMENTS

IDENTIFICATION DE L'USAGER

No. DOSSIER : _____

NOM À LA NAISSANCE : _____

PRÉNOM : _____ SEXE : ☐ F ☐ M

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____ TÉL. : _____

DATE DE NAISSANCE : ____/____/____

N.A.M. : _____ EXP. : ____/____

POIDS : _____ kg _____ lb

TAILLE : _____ cm _____ po

DATE DU POIDS : _____

DATE DE LA TAILLE : _____

☐ AUCUNE ALLERGIE

☐ AUCUNE INTOLÉRANCE

☐ ALLERGIE :

☐ INTOLÉRANCE :

Description de la réaction :

Description de la réaction :

GROSSESSE : _____ semaines

☐ Allaitement maternel

NOM	DOSE	VOIE	FRÉQUENCE	DURÉE*	RELEVÉ SOINS INF.

***LA DURÉE DE TRAITEMENT DES ANTIBIOTIQUES DOIT ÊTRE PRÉCISÉE**

JUSTIFICATION MÉDICAMENT D'USAGE RESTREINT :

Espace réservé étampe FAXÉ

*****TOUTE ORDONNANCE ILLISIBLE SERA RETOURNÉE AU PRESCRIPTEUR*****

Étampe prescripteur

Signature prescripteur : _____ N° de permis : _____

Date : _____ Heure : _____

Chaque ordonnance ne doit être faxée qu'une seule fois à la pharmacie. Toute modification subséquente doit être faite sur un autre formulaire.

GUIDE PRATIQUE SUR LA THROMBOPROPHYLAXIE MÉDICALE – MISE À JOUR FÉVRIER 2022

PATIENTS MÉDICAUX ET ADMIS AUX SOINS INTENSIFS

INDICATIONS À LA THROMBOPROPHYLAXIE	CONTRE-INDICATIONS À LA THROMBOPROPHYLAXIE PHARMACOLOGIQUE
Usager recevant des soins médicaux aigus avec facteurs de risque (Padua Prediction Score ≥ 4) Usager admis aux soins intensifs	Saignement actif Anticoagulation à dose thérapeutique AVC hémorragique récent (< 48 heures) Antécédent de thrombocytopénie induite à l'héparine (TIH)
Si contre-indication ou présence de plusieurs facteurs additionnels de saignement, la prophylaxie mécanique est à envisager : bas à compression intermittente ou bas anti-emboliques À NOTER : Il faut habituellement plusieurs facteurs de risques pour considérer que le patient a un risque élevé de saignement.	Facteurs additionnels de saignement ▪ Âge > 85 ans ▪ Saignement significatif dans les 3 mois de l'admission ▪ Insuffisance hépatique sévère ($\text{INR} > 1,5$) ▪ Insuffisance rénale sévère ($\text{Cl}_{\text{cr}} < 30$ mL/min) ▪ Décompte plaquettaire entre 30 et 50 $\times 10^9$ ▪ Utilisation concomitante de 2 antiplaquettaires ▪ Risque de saignement relié une chirurgie

➤ SOINS MÉDICAUX : PADUA PREDICTION SCORE

FACTEURS DE RISQUE	POINTS	
Cancer actif avec métastase et/ou chimio ou radiothérapie dans les 6 mois	3	Si score < 4 : Thromboprophylaxie (pharmacologique ou mécanique) n'est pas indiquée Si score ≥ 4 : thromboprophylaxie pharmacologique est indiquée . Utiliser la prophylaxie mécanique si contre-indication ou risque de saignement.
Antécédent de thromboembolie veineuse	3	
Mobilité réduite (alitement avec privilège de salle de bain pour ≥ 3 jours)	3	
Thrombophilie connue	3	
Traumatisme récent et/ou chirurgie récente (≤ 1 mois)	2	
Âge ≥ 70 ans	1	
Insuffisance cardiaque et/ou respiratoire	1	
Infarctus du myocarde aigu ou ACV ischémique	1	
Infection aiguë et/ou pathologie rhumatologie	1	
Obésité ($\text{IMC} \geq 30$)	1	
Traitement hormonal en cours	1	

AGENTS PHARMACOLOGIQUES

Énoxaparine 40 mg SC DIE ou 30 mg SC DIE – selon fonction rénale et poids

Daltéparine 5 000 unités SC DIE

Héparine 2 500 à 5000 unités SC BID ou TID

OBÉSITÉ

Énoxaparine 30 mg SC BID ou 40 mg SC BID ou 60 mg SC BID – selon fonction rénale et IMC

Daltéparine 7 500 unités SC DIE

Héparine 7 500 unités SC BID ou TID

ANTÉCÉDENTS DE TIH : Fondaparinux 2,5 mg SC DIE si poids > 50 Kg et $\text{Cl}_{\text{cr}} > 30$ mL/min

CARACTÉRISTIQUES	CONDUITE SUGGÉRÉE	CARACTÉRISTIQUES	CONDUITE SUGGÉRÉE
Insuffisance rénale ($\text{Cl}_{\text{cr}} < 30$ mL/min)	Héparine 5000 unités SC BID ou TID Énoxaparine 30 mg SC DIE Daltéparine 5000 unités SC die	Insuffisance rénale ($\text{Cl}_{\text{cr}} < 30$ mL/min) ET obésité	Héparine à 7500 unités SC BID ou TID peu importe l'IMC IMC > 40 et ≤ 50 : Énoxaparine 30 mg SC BID IMC > 50 : Énoxaparine 40 mg SC BID
Obésité (IMC > 40 et ≤ 50)	Énoxaparine 40 mg SC BID Daltéparine 7500 unités SC DIE Héparine à 7500 unités SC BID ou TID	Poids < 45 kg	Énoxaparine 30 mg SC DIE Héparine 2500 à 5000 unités SC bid Daltéparine 2500 unités SC DIE
Obésité (IMC > 50)	Énoxaparine 60 mg SC BID	Antécédent de TIH, poids > 50 Kg ET $\text{Cl}_{\text{cr}} > 30$ mL/min	Fondaparinux 2,5 mg SC die
Insuffisance rénale ($\text{Cl}_{\text{cr}} < 10$ mL/min ou dialyse)	Conduite individualisée	Patient sous épidurale	Conduite individualisée, éviter Rivaroxaban à discuter avec anesthésiologiste